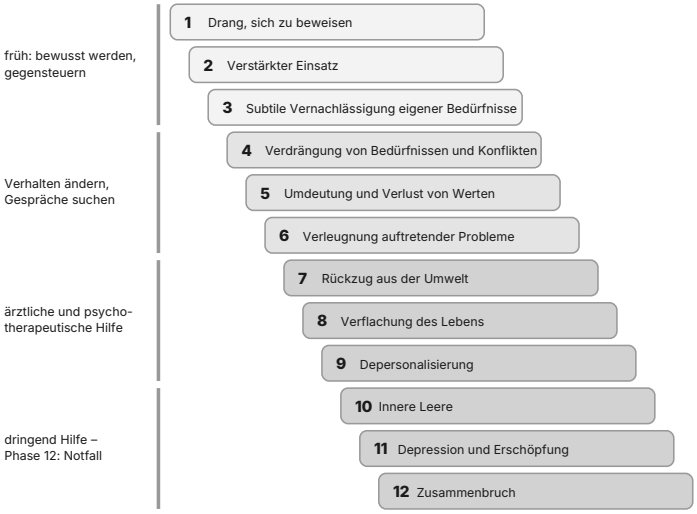
Burn-out, Helfersyndrom & Stressbewältigung

Stress verstehen, Burn-out erkennen, sich selbst schützen – nach Folien „Burnout-Syndrom“ und I care Kap. 2.7

Stress · Eustress/Disstress · Alarmreaktion · Lazarus · Coping · Ressourcen · Burn-out · 12 Phasen · Freudenberger · Abgrenzung Depression · Helfersyndrom · Prophylaxe · Eisenhower · PMR · Supervision



Linke Spalte: Orientierung zum Arbeitsauftrag (Folie 16) – Übergänge sind fließend.

INHALTE DIESES LERNHEFTS

- Stress: Definition, Alarmreaktion, Dauerstress
- Transaktionales Stressmodell nach Lazarus
- Belastungen im Pflegeberuf
- Burn-out: Definition, Ursachen, Symptome
- 12 Phasen nach Freudenberger und North
- Abgrenzung Burn-out und Depression
- Helfersyndrom nach Schmidbauer
- Prophylaxe und Stressbewältigung
- Lösungen Übungsfragen 14–17
- Glossar A–Z

Quellen: M. Pahler, CE 11.3 „Ausweglos“ – Burnout-Syndrom (Folien, BBG); I care Pflege, Kap. 2.7 Selbstfürsorge und Stressmanagement (Thieme); NVL Unipolare Depression 3.2, Kap. 2.4.3 Abgrenzung Depression und Burnout-Syndrom; Übungsfragen CE 11.3. Alle Abbildungen sind eigene schematische Zeichnungen. Zusammenfassung für den persönlichen Lerngebrauch – Luca Maranta (LM) · P1 O 25.1

Inhaltsverzeichnis

Lernheft Burn-out · 9 Kapitel + Glossar

1 **Stress**
Definition nach Selye · Eustress/Disstress · Alarmreaktion · Dauerstress

2 **Stressmodell nach Lazarus**
primäre und sekundäre Bewertung · Ressourcen · Coping · Neubewertung

3 **Belastungen in der Pflege**
Stressauslöser · Krankenstand · was trotzdem trägt

4 **Burn-out-Syndrom**
Definition · Auslöser · Gefährdete · Entwicklung · Symptome

5 **Die 12 Phasen nach Freudenberger**
vom Drang, sich zu beweisen, bis zum Zusammenbruch · wann handeln?

6 **Burn-out und Depression**
Abgrenzung · Erschöpfungsdepression · Vulnerabilitäts-Stress-Modell

7 **Helfersyndrom**
Schmidbauer · Merkmale · Teufelskreis · Auswege

8 **Vorbeugen und bewältigen**
Prophylaxe · Ressourcen · Einstellung · Zeitmanagement · Entspannung · Supervision

9 **Übungsfragen – Lösungen**
Fragen 14–17 aus dem Übungsblatt CE 11.3

A–Z **Glossar**
Fachbegriffe mit deutscher Übersetzung und Kurzerklärung

1 Stress

Definition nach Selye · Eustress/Disstress · Alarmreaktion · Dauerstress

> **Stress** ist nach Hans Selye („Vater der Stressforschung“) eine **unspezifische Reaktion des Körpers auf jede an ihn gestellte Anforderung** – eine körperliche und seelische Anspannung und Belastung. Der Begriff stammt aus der Physik (Zug auf ein Material, Materialermüdung).

	Eustress	Disstress
Bedeutung	„eu“ = gut – positiver Stress	„dis“ = schlecht – negativer Stress
Erleben	nicht als Belastung empfunden, z. B. bei Tätigkeiten mit viel Freude und Leidenschaft	über längere Zeit belastend – körperlich, geistig, seelisch
Folge	belebend, fördert die Leistungsfähigkeit	macht krank, kann zum **Burn-out** führen

Die körperliche Alarmreaktion

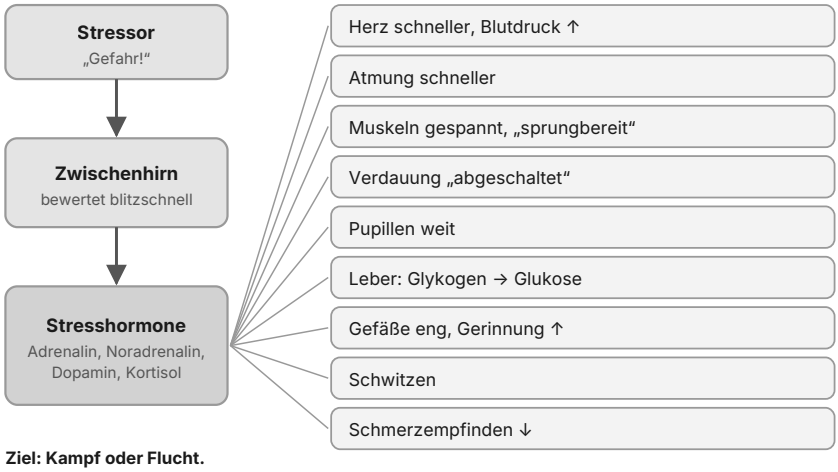


Abb. 1 Alarmreaktion: Das Zwischenhirn bewertet einen Reiz als Gefahr, Stresshormone versetzen den Körper in Kampf- oder Fluchtbereitschaft (nach I care, Beispiel „Löwe“).

Die Reaktion sicherte unseren Vorfahren das Überleben. Heute laufen dieselben Reaktionen ab, wenn wir uns **seelisch oder sozial** bedroht fühlen – obwohl Kampf oder Flucht dann meist keine Lösung sind. Je höher das **Stressniveau** (Ausprägung der Alarmreaktion), desto stärker die körperlichen Begleitsymptome und Gefühle.

Kurzfristige Stressreaktionen

- Muskelspannung
- Erblassen, Erröten, Schwitzen
- Kreislaufstörungen, Schwindel, Ohrensausen
- Herzstiche, Herzrasen
- Übelkeit, „Schmetterlinge im Bauch“
- Harndrang

Langfristige Stressreaktionen

- Muskelverspannungen, Rückenschmerzen
- Erschöpfung, Schlafstörungen, Kopfschmerzen
- Erkältungskrankheiten
- Nervosität, Gereiztheit
- Bluthochdruck, Arteriosklerose, Magenbeschwerden
- niedergeschlagene Stimmung, **Depression**
- Rauchen, Alkohol, Medikamente als Stressfolge

MERKE

Stress ist **nicht grundsätzlich schlecht**: Er mobilisiert Energie, steigert die Leistung, fokussiert die Aufmerksamkeit und hilft, Neues zu wagen. **Gesundheitsschädlich** wird er, wenn Erholungsphasen ausbleiben und Stress zum Normalzustand wird – der Stresshormonpegel bleibt dann dauerhaft erhöht (Dauerstress, Teufelskreis).

Beispiel Dauerstress laut I care: Tinnitus ist an die Kortisolausschüttung gekoppelt – bleibt Kortisol erhöht, bleibt das Pfeifen.

KURZ GEFRAGT

1. Wie definiert Selye Stress?
2. Was unterscheidet Eustress und Disstress?
3. Wann wird Stress gesundheitsschädlich?

Lösung: 1. unspezifische Reaktion des Körpers auf jede Anforderung · 2. Eustress belebt, Disstress belastet und macht krank · 3. wenn Erholung ausbleibt und Stress zum Dauerzustand wird

2 Stressmodell nach Lazarus

primäre und sekundäre Bewertung · Ressourcen · Coping · Neubewertung

Warum stresst dieselbe Situation den einen mehr als die andere? Nach Richard **Lazarus** entsteht Stress weniger durch das Ereignis selbst als durch dessen **Bewertung**. Situation und Person beeinflussen sich wechselseitig (= Transaktion).

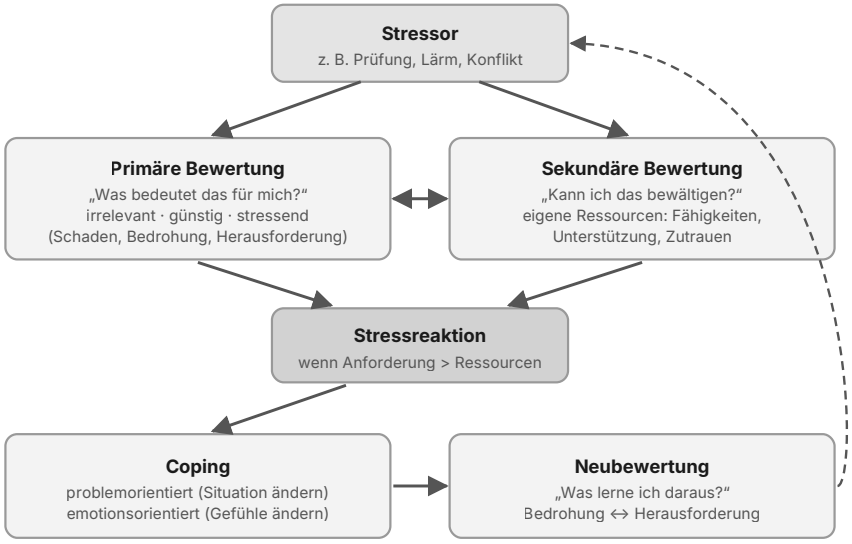


Abb. 2 Transaktionales Stressmodell nach Lazarus. Stress entsteht, wenn die Anforderungen die eigenen Ressourcen übersteigen.

Schritt	Frage	Inhalt
Stressor	–	Ereignis oder Situation, die Stress auslöst: Überforderung, Lärm, Isolation, Schmerzen, Krankheit oder Tod einer Bezugsperson
Primäre Bewertung	Was bedeutet das Ereignis für mein Wohlbefinden?	**irrelevant** · **günstig** (z. B. Fortbildung) · **stressend**: Schaden/Verlust, Bedrohung oder Herausforderung
Sekundäre Bewertung	Kann ich die Situation bewältigen?	Einschätzung der eigenen **Ressourcen**: Fähigkeiten, Möglichkeiten, das Gefühl, es zu schaffen (Widerstandsfähigkeit, soziale Unterstützung)

Schritt	Frage	Inhalt
Coping	Was kann ich tun?	**problemorientiert**: Situation, Ziele, Einstellungen ändern (Informationen suchen, handeln, Unterstützung holen) · **emotionsorientiert**: Gefühle beeinflussen, ohne die Situation zu ändern (Sinngebung, positive Umdeutung, Distanzierung, Ablenkung, Sport)
Neubewertung	Was kann ich daraus lernen?	Erfolgreich bewältigt → nächstes Mal eher Herausforderung als Bedrohung – und umgekehrt

Ressourcen sind individuelle Möglichkeiten und Fähigkeiten, Stressoren zu bewältigen: körperliche, psychische, geistige, soziale und materielle Ressourcen.

BEISPIEL AUS I CARE · KLAUSUR

Clara und Laura sind gleich gut vorbereitet. **Laura** bewertet die Klausur als **Bedrohung** („Ich darf mir keinen Ausrutscher leisten") – sie zweifelt an ihren Ressourcen, hat Herzrasen, Übelkeit, Blackout-Gefühl. **Clara** ist auch aufgeregt, bewertet die Klausur aber als **Herausforderung** und vertraut auf ihre Vorbereitung. Gleicher Stressor – unterschiedliche Bewertung – unterschiedlicher Stress.

MERKE

Entscheidend für erfolgreiche Bewältigung ist nicht *eine* „richtige" Copingstrategie, sondern die Fähigkeit, verschiedene Strategien **flexibel und situationsangemessen** einzusetzen.

KURZ GEFRAGT

1. Welche Frage stellt die sekundäre Bewertung?
2. Nenne je ein Beispiel für problem- und emotionsorientiertes Coping.
3. Wann entsteht nach Lazarus Stress?

Lösung: 1. Kann ich die Situation bewältigen? · 2. z. B. Hilfe holen / Sport, Umdeutung · 3. wenn die Anforderungen die eigenen Ressourcen übersteigen

3 Belastungen in der Pflege

Stressauslöser · Krankenstand · was trotzdem trägt

Stressauslöser (Befragung von Pflegenden)

- schweres Heben und Tragen
- große Verantwortung, ständige Aufmerksamkeit
- Termin- und Leistungsdruck
- zu viele administrative Tätigkeiten
- störende Unterbrechungen
- „herausfordernde" Pflegeempfänger und Angehörige, schwere Schicksale
- ständige Konfrontation mit Sterben und Tod
- Menschen mit Demenz, undankbare oder aggressive Menschen
- Vereinbarkeit von Familie, Schichtdienst und Freizeit

Psychisch besonders belastend (Aussagen Pflegender)

- Enttäuschung über die Grenzen der Medizin
- Patienten erinnern an eigene Angehörige
- unrealistische Heilungserwartungen
- Miterleben langer Krankheitsprozesse, Tod mehrerer Patienten
- beim Einschlafen an Patienten denken
- Fragen nach dem Sinn der eigenen Arbeit
- kein Raum für Gespräche mit Kollegen

Zahlen (TK-Gesundheitsreport 2019, I care)	Pflege vs. alle Beschäftigten
Krankheitstage pro Jahr	ca. 23 vs. 15 Tage (über 50 % mehr)
Fehltage wegen psychischer Diagnosen	4,63 vs. 2,47 Tage (ca. 87 % mehr)
Fehltage wegen Muskel-Skelett-Erkrankungen	4,78 vs. 2,61 Tage (ca. 83 % mehr)

MERKE

Aber: Pflegende erleben ihre Arbeit oft als **sinnstiftend**, interessant und abwechslungsreich, mit persönlicher Bestätigung, Handlungsspielräumen und täglichem Lernen. Wer die Stressauslöser kennt, kann gezielt gegensteuern.

4 Burn-out-Syndrom

Definition · Auslöser · Gefährdete · Entwicklung · Symptome

Syndrom = Anhäufung von Symptomen. Das **Burn-out-Syndrom** ist ein **chronischer körperlicher und geistiger Erschöpfungszustand** mit Krankheitsgefühl, der **länger als 6 Monate** andauert. Es ist meist Folge einer lang anhaltenden Stressbelastung, bei der der Körper die biochemischen Stressreaktionen nicht mehr verarbeiten kann.

NVL Unipolare Depression: Burn-out ist **keine eigene Krankheitsdiagnose**. In der ICD-10 wird es als Zusatzdiagnose **Z73.0** („Ausgebranntsein", Probleme bei der Lebensbewältigung) erfasst, in der ICD-11 als Risikofaktor für psychische Erkrankungen wie Depression oder Sucht. Burn-out-Symptome können Hinweis auf eine zugrunde liegende Depression sein und müssen ernst genommen werden.

Auslöser und gefährdete Personen

Häufige Auslöser

- anhaltender Stress
- hoher Druck und hohe Verantwortung in Beruf und Privatleben
- wenig Respekt, Vertrauen, Lob und Anerkennung
- chronische Überlastung; mehr Leistung bei weniger Personal
- Zeit- und Leistungsdruck, häufige Veränderungen

Besonders gefährdet

- **leistungsorientierte, perfektionistische** und idealistische Menschen, die sich keine Fehler erlauben
- **helfende Berufe**: Pflegende, pflegende Angehörige, Sozialarbeit, Therapie, Ärzt*innen, Lehrkräfte; auch mittleres Management
- Menschen mit ausgeprägtem **Helfersyndrom**

Entwicklung

1. Ein Burn-out entwickelt sich **langsam**. Erste Warnsignale: starke Schwankungen der Leistungsfähigkeit, Arbeit und Freizeit können nicht mehr getrennt werden.
2. Gedanklich immer bei der Arbeit, sich beweisen wollen, mehr arbeiten, eigene Bedürfnisse vernachlässigen.
3. Zunehmend gereizt und ungeduldig, keine richtige Erholung mehr.
4. Rückzug, Verlust der Motivation.
5. Die Leistungsfähigkeit sinkt, Betroffene sind isoliert und sehen keinen Ausweg aus dem Teufelskreis.

Symptome

Seelisch	Körperlich
Frustration, Versagensängste, Überforderung, Ängstlichkeit, depressive Verstimmung; nicht mehr abschalten können; „leer im Kopf“ (Denk- und Konzentrationsschwäche); Lustlosigkeit, Gleichgültigkeit; Ungeduld, Launenhaftigkeit; keine Identifikation mehr mit der Arbeit; Rückzug von Kollegen und Freunden	chronische Müdigkeit, Verspannungen, Kopf- und Rückenschmerzen, Herzrhythmusstörungen, Herz-Kreislauf- und Magen-Darm-Beschwerden, **Schlafstörungen** (oft erstes Warnsignal), Libidoverlust, Neigung zu viel Alkohol oder Kaffee

Häufig kommen **private Probleme** dazu (Partnerschaft, Freunde, Familie), die Verzweiflung und Überforderung verstärken.

> **MERKE**
>
> **Die fehlende Beziehung zu sich selbst:** Burn-out entsteht nicht nur durch Überlastung und chronischen Stress, sondern auch durch eine **verminderte Selbstwahrnehmung**. Betroffene definieren sich oft nur über Leistung und spüren nicht mehr, was sie brauchen und was ihnen guttut. Eine differenzierte Selbstwahrnehmung hilft, die eigenen Ressourcen gut einzusetzen.

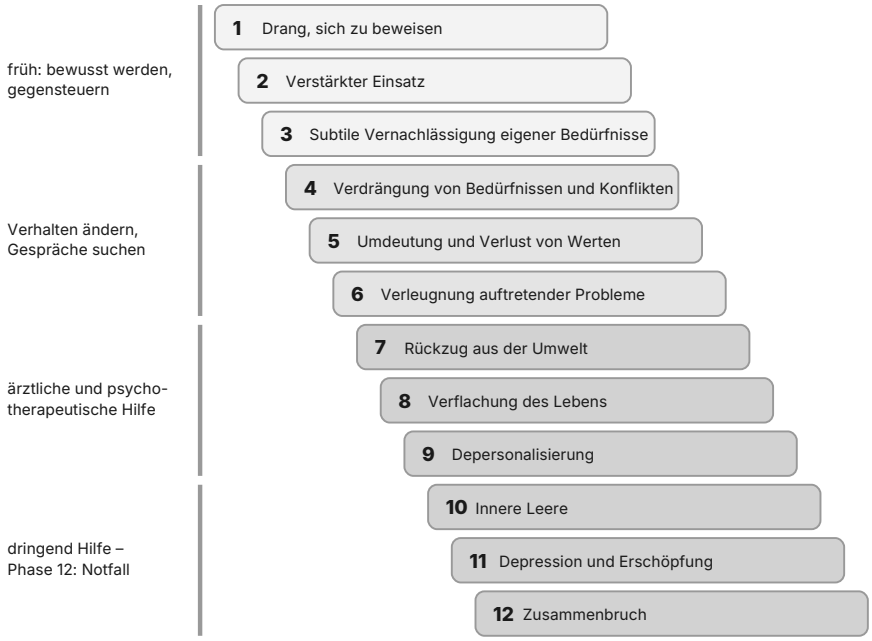
KURZ GEFRAGT

1. Wie lange besteht der Erschöpfungszustand beim Burn-out mindestens?
2. Welche Berufsgruppen sind besonders gefährdet?
3. Was ist oft das erste körperliche Warnsignal?

Lösung: 1. länger als 6 Monate · 2. helfende Berufe (Pflege, Sozialarbeit, Lehrkräfte …), auch mittleres Management · 3. Schlafstörungen

5 Die 12 Phasen nach Freudenberger

vom Drang, sich zu beweisen, bis zum Zusammenbruch · wann handeln?



Linke Spalte: Orientierung zum Arbeitsauftrag (Folie 16) – Übergänge sind fließend.

Abb. 3 12 Phasen des Burn-outs nach Freudenberger und North (1992). Individuelle Ausprägungen und Überschneidungen sind normal und keine Ausnahme.

Phase	Kennzeichen (nach Folien 17–28)
1. Drang, sich zu beweisen	große Ziele, viel Enthusiasmus; Druck, sich überall zu beweisen; möchte alle zufriedenstellen; körperliche Symptome selten
2. Verstärkter Einsatz	mehr Energie und Zeit; Gefühl, unentbehrlich zu sein; noch idealistisch und begeistert
3. Subtile Vernachlässigung eigener Bedürfnisse	Pausen fallen weg; mehr Koffein, Aufputschmittel, Zigaretten; Einschlafprobleme, „vergisst" zu essen; öfter krank, Kopfschmerzen, Magen-Darm
4. Verdrängung von Bedürfnissen und Konflikten	Hobbys rücken in den Hintergrund, zu Hause nur noch Ruhe; Fehlleistungen (Termine vergessen); erschöpft; Wohlbefinden an beruflichen Erfolg gekoppelt
5. Umdeutung und Verlust von Werten	Arbeit wichtiger als alles andere; Freunde und Partner vernachlässigt; weniger Sexualität und Sport; Stresshormone werden nicht abgebaut
6. Verleugnung auftretender Probleme	leugnet Stress gegenüber anderen; merkt nicht, dass die Arbeit nicht mehr zu schaffen ist; Enttäuschungen werden „heruntergeschluckt"; Fehlzeiten
7. Rückzug aus der Umwelt	fühlt sich unverstanden, zieht sich zurück; Zynismus; Ersatzbefriedigung durch Essen, Alkohol, Drogen; psychosomatische Beschwerden ohne Befund
8. Verflachung des Lebens	nichts macht mehr Spaß; ärgerlich auf Zuwendung, Einsamkeit, Selbstmitleid; Gleichgültigkeit, Sinnlosigkeit; negative Denkweisen
9. Depersonalisierung	Verlust des natürlichen Gefühls für die eigene Persönlichkeit; „funktioniert wie eine Maschine"; versteht sich selbst nicht mehr
10. Innere Leere	Wechsel zwischen starken Gefühlen und innerem Abgestorbensein; Sinnfragen; heftiges Weinen; Panikattacken, Ängste; Einsamkeit
11. Depression und Erschöpfung	Hoffnungslosigkeit, existenzielle Verzweiflung; Bild wie bei schwerer Depression; Wunsch, nicht mehr aufzuwachen; Suizidgedanken können akut lebensbedrohlich werden
12. Zusammenbruch	lebensgefährliche emotionale, geistige und körperliche Erschöpfung – **absoluter Notfall**, stark erhöhte Suizidalität

ARBEITSAUFTRAG FOLIE 16 · LÖSUNGSVORSCHLAG

Ab wann sich aktiv mit der eigenen Lebenswelt auseinandersetzen? Möglichst früh – spätestens in **Phase 3**, wenn eigene Bedürfnisse (Pausen, Essen, Schlaf) vernachlässigt werden und Aufputschmittel zunehmen. In Phase 4–5 (Hobbys, Freunde, Sport fallen weg) ist eine Verhaltensänderung dringend.

Ab wann Ärztin/Arzt oder Psychotherapie? Wenn körperliche Beschwerden zunehmen, Probleme verleugnet werden und Rückzug, Zynismus oder Ersatzbefriedigung durch Alkohol/Drogen auftreten (**Phase 6–7**), spätestens bei Verflachung, Depersonalisierung und innerer Leere (Phase 8–10). Ab **Phase 11** braucht es dringend Hilfe, **Phase 12** ist ein Notfall.

Die Grenzen sind fließend und individuell – das ist eine Orientierung für die Diskussion im Plenum, keine feste Regel.

I care beschreibt zusätzlich ein vereinfachtes Modell mit 10 Phasen: vom engagierten Beginn über Überforderung, Schuldgefühle und Hilflosigkeit bis zur totalen Gefühlsleere (Erschöpfungszustand).

KURZ GEFRAGT

1. Nenne drei Phasen nach Freudenberger.
2. In welcher Phase taucht oft Zynismus auf?
3. Was kennzeichnet Phase 12?

Lösung: 1. z. B. Drang, sich zu beweisen – Verleugnung auftretender Probleme – Innere Leere · 2. Phase 7 (Rückzug aus der Umwelt) · 3. Zusammenbruch: absoluter Notfall, stark erhöhte Suizidalität

6 Burn-out und Depression

Abgrenzung · Erschöpfungsdepression · Vulnerabilitäts-Stress-Modell

	Burn-out	Depression
Bezug	meist **situationsbezogen** (z. B. Arbeit), greift erst später auf andere Lebensbereiche über	wirkt sich **von Beginn an auf alle Lebensbereiche** aus
Entstehung	Prozess: ständige Belastung → Überlastung	multifaktoriell; oft kein erkennbarer Prozess, Episoden
Abwertung	Distanzierung und Abwertung, oft als **Zynismus**	Zynismus tritt nicht auf; eher Schuld und Selbstabwertung
Diagnose	keine eigene Krankheitsdiagnose (ICD-10 Z73.0)	Krankheitsdiagnose nach ICD-10 (F32/F33)
Volle Ausprägung	praktisch **kein Unterschied** mehr – man spricht von einer **Erschöpfungsdepression**	

Vulnerabilitäts-Stress-Modell (Diathese-Stress-Modell)

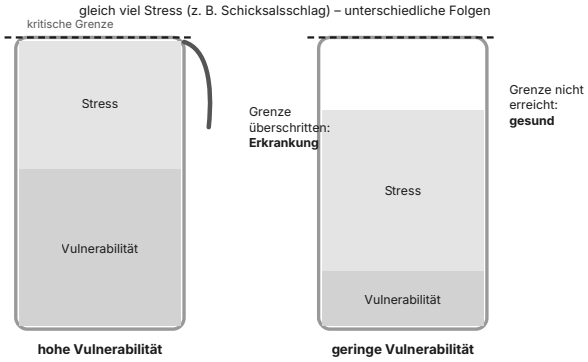


Abb. 4 Diathese-Stress-Modell: Beide Faktoren sind nötig. Gleich belastende Ereignisse können bei Person B eine Depression auslösen, bei Person A nicht.

- **Diathese/Vulnerabilität** = Krankheitsneigung, genetisch oder lerngeschichtlich bedingt: die Neigung, auf eine bestimmte Weise auf Belastungen zu reagieren.
- **Stressoren** = belastende Ereignisse oder Lebenssituationen, z. B. Pflege von Angehörigen, Partnerschaftskonflikte, Geldsorgen, Arbeitsbelastung.
- Werden die Belastungen zu groß und überschreiten eine **Schwelle**, bricht die Krankheit aus. Die Schwelle wird durch **Risiko- und Schutzfaktoren** verschoben (z. B. soziale Unterstützung).
- Person A kann z. B. durch **selbstwertstärkende Erfahrungen** in ihrer Biografie oder „bessere“ Gene weniger vulnerabel sein.

KURZ GEFRAGT

1. Nenne zwei Unterschiede zwischen Burn-out und Depression.
2. Was ist eine Erschöpfungsdepression?
3. Was verschiebt die Schwelle im Diathese-Stress-Modell?

Lösung: 1. z. B. situationsbezogen vs. alle Lebensbereiche; Zynismus nur beim Burn-out · 2. voll ausgeprägtes Burn-out, nicht mehr von Depression zu unterscheiden · 3. Risiko- und Schutzfaktoren, z. B. soziale Unterstützung

7 Helfersyndrom

Schmidbauer · Merkmale · Teufelskreis · Auswege

Das **Helfersyndrom** beschrieb der Psychoanalytiker **Wolfgang Schmidbauer** in den 1970er-Jahren („Die hilflosen Helfer"). Betroffene haben das Ideal verinnerlicht, nur dann gut und wertvoll zu sein, wenn sie anderen – Schwächeren, Kranken, Bedürftigen – helfen.

Kennzeichen

- gesteigerte Hilfs- und Aufopferungsbereitschaft; eigene Bedürfnisse scheinbar hinter denen der anderen
- das „Gefühl des Gebrauchtwerdens" **versteckt eigene psychische oder soziale Probleme**
- hilft ungefragt, kann schwer **Nein** sagen, macht Probleme anderer zu eigenen
- ignoriert, ob die Hilfe erwünscht und sinnvoll ist – Hilfe wird **aufgedrängt**; kann sogar schaden, weil der andere nicht selbst handelt
- schwaches Selbstwertgefühl, oft in der Kindheit gelernt; Helfen wird zur „Sucht"
- lehnt Hilfe für sich selbst ab

Bedürfnisse dahinter

Der „pathologische Helfer" ist abhängig vom Helfen. Es befriedigt zwei Bedürfnisse: nach **Zugehörigkeit** und nach **Bestätigung des Eigenwerts** – bei solidarischer Hilfe bleiben sie im Hintergrund, beim Helfersyndrom sind sie die treibende Kraft.

Häufig in sozialen Berufen: Lehrkräfte, Ärzt*innen, Pflegende, Psycholog*innen, Sozialarbeit, Seelsorge.

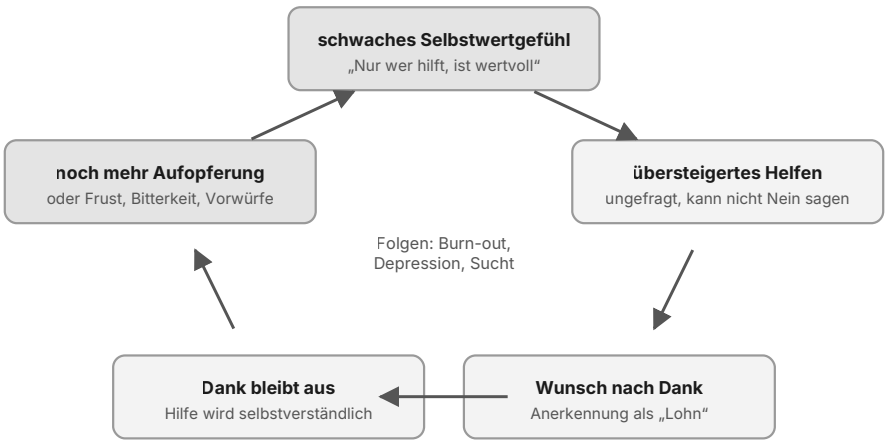


Abb. 5 Teufelskreis des Helfersyndroms (nach Folie 37).

Häufige Folgen der ständigen Belastung: **Depression, Angststörungen, Burn-out, psychosomatische Störungen, Sucht**.

AUSWEGE

Ehrlich zu sich sein und Bilanz ziehen: *Bleibt neben meiner Hilfe genug Energie für mich? Befürchte ich weniger Liebe und Anerkennung, wenn ich weniger helfe?* Experten raten:

- **Neinsagen** lernen
- sich vom Jammern und Klagen anderer nicht irritieren lassen
- nicht sofort zu Hilfe eilen
- Balance zwischen Geben und Nehmen; eigene Grenzen und den echten Bedarf des anderen beachten

Das schlechte Gewissen am Anfang ist normal – mit wachsender Achtsamkeit für eigene Bedürfnisse steigt der Selbstwert.

8 Vorbeugen und bewältigen

Prophylaxe · Ressourcen · Einstellung · Zeitmanagement · Entspannung · Supervision

Burn-out-Prophylaxe (Folie 14)

- körperliche Bewegung
- Autogenes Training
- Progressive Muskelentspannung nach Jacobson
- Achtsamkeitsübungen, Meditation
- Atemübungen (auch Stimulation des Vagusnervs)
- Stärkung des sozialen Netzes
- Zeiten ohne Medien, Lärm und Aufgaben (**Reizreduktion**)
- individuelle „Energieräuber" – auch Personen – meiden
- alles, was individuell guttut

Aktive Stressbewältigung (I care)

1. persönliche Stressbelastungen analysieren
2. verschiedene Methoden kennenlernen und ausprobieren
3. ein persönliches Antistressprogramm entwickeln
4. Zufriedenheit und Stressniveau regelmäßig überprüfen

Ansatz	Beispiele
Ressourcen stärken	**seelische Kräfte** („Was kann ich gut?"), **soziale Kontakte** („Wer kann mir helfen?"), **Wissen** über die Situation
Einstellung ändern	Verallgemeinerungen meiden („immer", „nie", „alle", „keiner"); **negative Glaubenssätze** erkennen („Ich muss besonders gut sein", „Alle müssen mich mögen", „Das schaffe ich nie"); Fortbildung z. B. gewaltfreie Kommunikation (Rosenberg)
Work-Life-Balance	Freizeit wirklich nutzen, **Zufriedenheitserlebnisse** ohne schlechtes Gewissen: machen Spaß ohne Nützlichkeit, wenig Aufwand, regelmäßig, mit Menschen, die man mag
Ziele entwickeln	positiv formulieren („Ich mache ein gutes Examen"), als schon erreicht formulieren („Ich bin …"), realistisch

Zeitmanagement – Eisenhower-Methode



Abb. 6 Eisenhower-Methode: Aufgaben nach wichtig/dringend sortieren. Das Feld „wichtig, nicht dringend" (Planung, Vorbeugung, Erholung) schützt vor dem Ausbrennen.

Entspannungsmethoden

Kurzfristig (in akuten Stresssituationen)

- Atemübung, z. B. **4-6-8-Methode**: Hand auf den Bauch, durch die Nase einatmen (bis 4 zählen), Luft halten (bis 6), durch den Mund ausatmen (bis 8)
- positives Selbstgespräch („Ich werde das schaffen!")
- kontrolliertes Abreagieren
- Gedankenstopp, an Positives denken
- Übungen „Quasimodo" (Nacken) und „King Kong" (Schultern, Arme): anspannen – halten – loslassen

Langfristig

- Bewegung: Spazierengehen, Joggen, Walken, Schwimmen, Radfahren, Tanzen
- Yoga, Qigong, Tai-Chi
- **Progressive Muskelentspannung** nach Jacobson: Muskelgruppen nacheinander leicht anspannen, dann bewusst entspannen – Atmung, Puls und Blutdruck beruhigen sich, Schlaf und Konzentration bessern sich

> **MERKE**
>
> Entspannung muss man **üben**: klein anfangen, feste Zeit einplanen, eine andere Methode wählen, wenn eine nicht passt.

Supervision und Unterstützung im Team

Supervision ist eine professionelle, personen- und organisationsbezogene Beratung in der Arbeitswelt: Fälle, Konflikte und Belastungen werden ohne Zeitdruck aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet – nicht um Schuldige zu finden, sondern um Handlungsalternativen zu entwickeln. Kosten trägt meist der Arbeitgeber; „Supervisor" ist kein geschützter Begriff.

PFLEGEBEZUG · KOLLEG*INNEN ANSPRECHEN

Soziale Unterstützung im Team hilft Betroffenen sehr. Fallen Symptome bei Kolleg*innen auf: ansprechen, **ohne Vorwurf** nur die eigene Wahrnehmung schildern und **Sorge ausdrücken** – Betroffene spüren oft selbst nicht, wie schlecht es ihnen geht. Zu ärztlichem und therapeutischem Rat ermutigen.

KURZ GEFRAGT

1. Nenne vier Maßnahmen der Burn-out-Prophylaxe.
2. Wie funktioniert die 4-6-8-Methode?
3. Welches Eisenhower-Feld wird oft unterschätzt?

Lösung: 1. z. B. Bewegung, PMR, Achtsamkeit, soziales Netz, Reizreduktion · 2. 4 Zählzeiten ein, 6 halten, 8 aus · 3. wichtig, aber nicht dringend (Planung, Vorbeugung, Erholung)

9 Übungsfragen – Lösungen

Fragen 14–17 aus dem Übungsblatt CE 11.3

Frage	Lösung
14. Grenzen Sie Burn-out von der Depression ab.	Burn-out ist meist **situationsbezogen** (Arbeit) und greift erst später auf andere Lebensbereiche über, eine Depression betrifft **von Anfang an alle Lebensbereiche**. Burn-out ist ein **Prozess** von ständiger Belastung zur Überlastung. Beim Burn-out wird im Zuge der Depersonalisierung vieles abgewertet, oft als **Zynismus** – das tritt bei Depression nicht auf. Burn-out ist keine eigene Diagnose (ICD-10 Z73.0), Depression schon. In voller Ausprägung kaum noch Unterschied: **Erschöpfungsdepression**.
15. Nennen Sie 3 Stadien des Burn-outs nach Freudenberger.	Aus den 12 Phasen, z. B.: 1. Drang, sich zu beweisen · 3. Subtile Vernachlässigung eigener Bedürfnisse · 6. Verleugnung auftretender Probleme · 7. Rückzug · 9. Depersonalisierung · 10. Innere Leere · 12. Zusammenbruch.
16. Welche Ursachen für Burn-out kennen Sie?	Anhaltender Stress; hoher Druck und hohe Verantwortung in Beruf und Privatleben; wenig Respekt, Vertrauen, Lob und Anerkennung; chronische Überlastung, Zeit- und Leistungsdruck, Personalmangel; Persönlichkeit: Perfektionismus, Leistungsorientierung, Idealismus, Helfersyndrom; **verminderte Selbstwahrnehmung**; zusätzliche private Probleme.
17. Wie kann man Burn-out vorbeugen?	Bewegung, Autogenes Training, Progressive Muskelentspannung, Achtsamkeit, Meditation, Atemübungen; soziales Netz stärken; Reizreduktion (Zeiten ohne Medien); Energieräuber meiden; Selbstwahrnehmung schulen; Grenzen setzen und Nein sagen; Work-Life-Balance und Zufriedenheitserlebnisse; Zeitmanagement (Eisenhower); realistische Ziele; Supervision; Kolleg*innen achtsam ansprechen; früh ärztliche/therapeutische Hilfe holen.

Glossar

Fachwort · deutscher Begriff · Kurzerklärung

Fachwort	Deutscher Begriff
Achtsamkeit	bewusste Wahrnehmung Den Moment wertfrei wahrnehmen; Burn-out-Prophylaxe durch Meditation und Übungen.
Alarmreaktion	körperliche Stressreaktion Ausschüttung von Stresshormonen, um Kampf oder Flucht zu ermöglichen.
Autogenes Training	Entspannung durch Selbstsuggestion Entspannungsverfahren mit formelhaften Vorsätzen (z. B. „Mein Arm ist schwer“).
Burn-out-Syndrom	Ausgebranntsein Chronischer körperlicher und geistiger Erschöpfungszustand mit Krankheitsgefühl, länger als 6 Monate.
Coping	Stressbewältigung Alle Anstrengungen, um einen Stressor oder seine Bedrohung zu verringern.
Depersonalisierung	Entfremdung von sich selbst Gefühl, nur noch wie eine Maschine zu funktionieren (Burn-out-Phase 9).
Diathese	Anfälligkeit, Disposition Krankheitsneigung; anderes Wort für Vulnerabilität (Diathese-Stress-Modell).
Disstress	negativer Stress Belastender Stress, der auf Dauer krank macht und zum Burn-out führen kann.
Eisenhower-Methode	Zeitmanagement nach Dringlichkeit und Wichtigkeit Aufgaben in 4 Felder einteilen: sofort, terminieren, delegieren, weglassen.
Emotionsorientiertes Coping	gefühlsbezogene Bewältigung Gefühle beeinflussen, ohne die Situation zu ändern, z. B. Umdeutung, Sport.
Erschöpfungsdepression	Depression nach Burn-out Volle Ausprägung des Burn-outs, praktisch nicht mehr von einer Depression zu unterscheiden.
Eustress	positiver Stress Belebender Stress, der die Leistungsfähigkeit fördert.
Helfersyndrom	krankhaftes Helfenwollen Übersteigerte Hilfsbereitschaft zur Stabilisierung des eigenen schwachen Selbstwerts (Schmidbauer).
Kortisol	Stresshormon der Nebennierenrinde Bei Dauerstress dauerhaft erhöht.
Primäre Bewertung	erste Einschätzung Lazarus: Was bedeutet das Ereignis für mich? irrelevant, günstig oder stressend.
Problemorientiertes Coping	lösungsbezogene Bewältigung Die Situation selbst verändern, z. B. Informationen suchen, Hilfe holen.
Progressive Muskelentspannung	PMR nach Jacobson Muskelgruppen nacheinander anspannen und bewusst entspannen.
Psychosomatisch	seelisch-körperlich Körperliche Beschwerden, die durch seelische Belastung entstehen oder verstärkt werden.
Ressourcen	Kraftquellen Individuelle Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Stressbewältigung (körperlich, psychisch, sozial, materiell).

Fachwort	Deutscher Begriff
Sekundäre Bewertung	Bewertung der eigenen Möglichkeiten Lazarus: Kann ich die Situation mit meinen Ressourcen bewältigen?
Selbstfürsorge	Sorge für sich selbst Achtsamer Umgang mit eigenen Bedürfnissen und Grenzen.
Stress	Belastungsreaktion Unspezifische Reaktion des Körpers auf jede Anforderung (Selye).
Stressor	Stressauslöser Ereignis oder Situation, die Stress hervorruft, z. B. Lärm, Überforderung.
Supervision	berufliche Beratung Begleitete Reflexion von Fällen, Konflikten und Belastungen im Team.
Syndrom	Symptomkomplex Anhäufung zusammengehöriger Symptome.
Transaktionales Stressmodell	Stressmodell nach Lazarus Stress entsteht aus der Wechselwirkung von Situation und Bewertung der Person.
Work-Life-Balance	Gleichgewicht von Arbeit und Privatleben Ausgewogenes Verhältnis von Beruf, Erholung und Familie.
Zynismus	verletzender Spott Abwertende Haltung; im Burn-out als Distanzierungsstrategie, bei Depression nicht typisch.

Quellen: M. Pahler: CE 11.3 „Ausweglos“ – Burnout-Syndrom, BBG · I care Pflege, Kap. 2.7 Selbstfürsorge und Stressmanagement, Thieme · NVL Unipolare Depression 3.2, Kap. 2.4.3 · Übungsfragen CE 11.3. Abbildungen: eigene schematische Zeichnungen.